Processo nº **0119156-08.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): M. C. M. H.
REPRESENTANTE: TARCIANA VANDERLEY DE MORAES HERCULANO

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** ajuizada por **M.C.M.H.**, neste ato representada por sua genitora, TARCIANA VANDERLEY DE MORAES HERCULANO (ID 185748975), e através de advogada constituída (ID 185750534), em face **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, todos devidamente qualificados.

Preliminarmente, a parte autora pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Narrou a autora que é segurada da parte ré, sob Código de Beneficiário nº 0343306000853007 (ID 185750540), e, tendo 13 (treze) anos de idade, é acompanhada pela médica Dra. Bárbara Gomes, especialista em endocrinologia pediátrica.

Após a realização de dois testes de estímulo para o hormônio do crescimento, foi constatada a deficiência de tal hormônio, recebendo a paciente, então, o diagnóstico de hipotuitarismo – CID E23.0. Assim, é acometida com baixa estatura, abaixo do percentual mínimo do padrão familiar e populacional.

Por tal razão, a médica assistente prescreveu o uso imediato de somatropina, na dose de 0,033mg/kg, com uso diário e contínuo, via subcutânea. De acordo com a especialista, *"não existe outro tratamento para este distúrbio e o*

paciente necessita de acompanhamento médico periódico durante todo o tratamento. A medicação deve ser fornecida com urgência devido ao fechamento contínuo da cartilagem de crescimento. Caso este medicamento não seja fornecido, o paciente atingirá estatura final abaixo da população, o que pode trazer prejuízos psicossociais significativos" (ID 185750544).

Todavia, embora o medicamento em epígrafe esteja no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de acordo com a autora, o plano de saúde recusou o custeio do tratamento por ausência de cobertura, conforme legislação setorial e contrato avençado entre as partes (ID 185750548).

Diante deste cenário, a demandante pleiteou, em sede de tutela de urgência, a cobertura, pela demandada, do integral tratamento com o fornecimento da somatropina, em consonância com a prescrição médica e pelo tempo necessário.

No mérito, além da confirmação da tutela, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, atribuiu à causa o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

Decisão inaugural (ID 185895306) deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita; **indeferiu a tutela provisória** de urgência e determinou a citação da ré para apresentar contestação.

Citada (ID 187121243), **a Unimed Recife** ofertou contestação sob ID 189206820. Requereu, de início, intimação exclusiva em nome do advogado PEDRO SOTERO BACELAR, OAB/PE nº 24.634. Arguiu as seguintes preliminares: **(1)** impugnação ao valor da causa, afirmando que, com base no orçamento apresentado pela autora, considerando o valor mais baixo da medicação, o custo anual do tratamento é de R$ 38.395,20, assim, acrescido dos danos morais (R$ 10.000,00), o valor correto da causa seria de R$ 48.395,20; **(2)** ausência de probabilidade do direito, por não ter a autora comprovado pressupostos processuais para o fornecimento da Somatropina, nos termos da Portaria nº 110/2010 do Ministério da Saúde (altura, peso e velocidade do crescimento).

No mérito, pugnou pela improcedência da ação, invocando, em síntese, os seguintes argumentos: **(1)** não obrigatoriedade de cobertura para medicamento de uso domiciliar, nos termos da Lei nº 9.656/98 (art. 10, inciso VI) e do contrato – Art. 31, inciso III, alínea "*m*" (ID 189210115, pág. 15); **(3)** é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; **(4)** o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo; **(5)** ausência de configuração de dano moral, até porque a negativa foi fundamentada em cláusula contratual e no exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito; e **(6)** necessidade de perícia e da juntada periódica da evolução do paciente.

A parte autora noticiou, no ID 189382912, a interposição do **Agravo de Instrumento nº 0054886-27.2024.8.17.9000** em face da decisão que indeferiu a tutela, pugnando pela retratação do *decisum*. No entanto, não juntou as razões do recurso.

Intimou-se a autora para apresentar réplica e ambas as partes para informarem interesse na produção de outras (ato ordinatório de ID 190231778).

A ré pugnou pela realização de "*perícia judicial médica, com o fito de estabelecer a verdade nos autos em epígrafe*" (ID 192150916).

A parte autora, por sua vez, ofertou réplica sob ID 193793841, sem apresentar requerimento acerca da produção de provas.

Determinou-se vista ao Ministério Público (despacho de ID 194557805), ao que o *parquet* noticiou que se manifestaria após decisão do juízo acerca da produção da prova pleiteada pela ré (ID 195019634).

Vieram-me conclusos.

É o que se tem a relatar. Passo a analisar e decidir.

À saída, registre-se que, conforme consulta ao PJE 2º Grau, em 26/02/2025, não foi concedido, até o momento, o efeito **suspensivo no** AI nº 0054886-27.2024.8.17.9000, estando o recurso pendente de julgamento**.**

Dito isso, verifico que o **presente feito comporta julgamento antecipado da lide**, pois não há necessidade de produção de prova, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC/2015.

Convém ressaltar que o CPC/2015 adota o sistema do convencimento motivado (ou persuasão racional), segundo o qual cabe ao julgador decidir pela necessidade ou não de se realizar determinada prova para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, pode o juízo indeferir as diligências que entender inúteis, se considerar que os elementos constantes nos autos já são suficientes para embasar a sua persuasão. Neste sentido, seguem julgados das turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. J***ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ***.** *REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO*

DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. **A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, os quais preceituam que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.** *4. (....) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.794/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,* **Terceira Turma***, julgado em 28/11/2022, DJe de* **9/12/2022***.)*

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, V, DO NCPC. INEXISTÊNCIA. **PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.** *NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2.* **Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.** *3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.567.720/SP, relator Ministro Raul Araújo,* **Quarta Turma***, julgado em 26/10/2020, DJe de* **24/11/2020***.)*

No caso vertente a ré pugnou pela realização de **perícia médica judicial "*com o fito de estabelecer a verdade nos autos em epígrafe*" (ID 192150916).**

No ponto, cumpre destacar que a jurisprudência pátria já tem se posicionado que, nos casos de expressa indicação médica, a produção de prova pericial só se mostra imprescindível quando haja indícios de prática de fraude ou tenham sido levantadas dúvidas consistentes acerca da credibilidade da prescrição. Em não sendo o caso dessas situações, a indicação do médico assistente deve prevalecer.

Neste sentido segue jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP):

> APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – **Pretensão de custeio de cirurgia reparatória pós-bariátrica – Recusa da operadora ao argumento de que os procedimentos não constam do rol de cobertura da ANS e têm natureza eminentemente estética – Alegação de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide – Presente a indicação médica, é dispensável a perícia – Ausentes indícios de prática de fraude ou dúvidas consistentes acerca da higidez da prescrição médica – Cerceamento de defesa não configurado** – Abusividade da negativa – Doença com cobertura contratual – Inteligência das súmulas nº 96 e 102, deste E. TJSP – Cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, com indicação médica, de caráter nitidamente reparador e não estético – Súmula nº 97, TJSP – Reconhecida a obrigação de custeio – Sentença de procedência mantida, com observação no tocante ao critério para fixação dos honorários advocatícios – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AC: 11354823520168260100 São Paulo, Relator: Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2018)

Não se visualiza motivo para determinação da prova pericial médica, posto que há nos autos laudo médico (ID 185750544) indicando o quadro de saúde da autora, bem como a prescrição da medicação.

Assim, diante do panorama descortinado, **reputo que não se afigura necessária a realização da perícia requerida**.

Neste ser assim, **indefiro a prova pericial requerida**.

Noutra banda, não merece prosperar a **preliminar de impugnação ao valor atribuído à causa** suscitada pela ré, tendo em vista que o valor da causa foi consignado nos termos do art. 292, V e VI, do CPC/2015, sendo equivalente a soma do valor dos danos morais (R$ 10.000,00) e do valor estimado para o tratamento

anual, qual seja, R$ 42.000,00, o que importa o valor mensal da medicação no montante de R$ 3.500,00, não destoando das quantias apontadas no orçamento de ID 185750553. Deste modo, **rejeito a preliminar**.

Quanto à segunda preliminar arguida, verifico que se confunde como a questão meritória, devendo ser apreciada no momento oportuno.

A questão fulcral para apreciação reside em identificar se o **fornecimento de medicamento para uso domiciliar** é ou não serviço de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, de conformidade com a legislação de regência, especificamente a Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

Impende destacar que os contratos de plano de saúde, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da **Súmula 608**: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Dito isso, merece registro que os medicamentos ora solicitados se reportam ao <u>hormônio do crescimento e puberdade precoce</u>, a serem ministrados **fora** do regime de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial de urgência ou de emergência. Para além disto, não se cuidam de medicações quimioterápicas oncológicas ou tratamento de neoplasia maligna, como igualmente não haverá internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.

Assim, diante do panorama fático descortinado, com esteio na própria prova colacionada aos autos pela parte autora, constata-se que em se tratando de <u>medicamentos ministrados fora do regime de internação hospitalar ou ambulatorial, não versando sobre tratamento de neoplasia ou quimioterapia oncológica, a exclusão de cobertura encontra suporte no art. 10, inciso VI da Lei 9.656/98:</u>

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a

internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigência mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**:

VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Para além disto, preconiza a Resolução Normativa 465/2021 da ANS:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

Neste ser assim, há cobertura para medicamentos de uso domiciliar apenas no que tange a quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento de câncer (inciso IX), bem como medicamentos antineoplásicos orais, como dispõe o inciso X, ambos do art. 18, da RN em relevo.

Deste modo, à luz desses dispositivos normativos, depreende-se que é lícita a exclusão de medicação para tratamento domiciliar convencional, já que a obrigatoriedade de fornecimento pelos planos de saúde externamente à unidade de saúde está restrita aos medicamentos antineoplásicos/quimioterápicos em tratamento oncológico.

Assim, a recusa pelo plano de saúde de custeio de medicamento – hormônio do crescimento/bloqueador de puberdade – para fins de tratamento terapêutico, não configura abusividade, até porque o medicamento receitado para o caso concreto não é serviço essencial à natureza do contrato de assistência à saúde, cuidando-se, em real verdade, de serviço excepcional, adicional.

Ademais, conquanto o laudo da endocrinologista assistente ateste a necessidade do tratamento, não se tratam de medicações prescritas como sendo essenciais para manutenção/preservação da vida/saúde/sobrevivência do paciente,

ou seja, não se infere dos termos ali expressos risco vital a lastrear a excepcionalidade da pretensão.

Nesse sentido, seguem julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJPE:

> RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. **TRATAMENTO. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES. MEDICAMENTO DOMICILIAR. NÃO OBRIGATORIEDADE PELA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO**. 1.1. **Em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (*home care*) e outros fármacos incluídos pela ANS no rol de fornecimento obrigatório**. 2. **Segundo o STJ "*lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar*", isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (*home care*) e os incluídos no rol da ANS para esse fim**. 3. Recurso não provido. Decisão unânime. (APELAÇÃO CÍVEL 0110047-72.2021.8.17.2001, Rel. ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC), julgado em **28/03/2023**, DJe)

> EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. **NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE**. 1. <u>Nos casos de urgência e emergência, em que o risco à vida se revele presente, admite-se interpretação extensiva do art. 10, VI, da lei 9.656/98 – que exclui da cobertura assistencial mínima o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar - para abranger o medicamento ministrado por orientação do médico assistente fora do regime de internação hospitalar, levando-se em conta a natureza do contrato de plano de saúde e a sua finalidade precípua de proteção à vida e à saúde do contratante</u>. 2. **Hipótese em que o tratamento medicamentoso pleiteado não se apresenta como terapia fundamental para a vida do paciente, mormente porque o laudo do médico assistente justifica a urgência do início do tratamento com o hormônio do crescimento tão somente no fato de a menor ficar com "altura final muito abaixo do padrão populacional feminino e genético"**. 3. Apelação a que se dá provimento. (APELAÇÃO CÍVEL 0000272-

59.2020.8.17.2001, Rel. FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC), julgado em **31/08/2022**, DJe)

Acrescente-se, no ponto, consoante julgado da 5ª Câmara Cível do TJPE, da lavra do Des. José Fernandes de Lemos, no bojo do Agravo de Instrumento nº 0013093-03.2017.8.17.2001, que "*não é razoável obrigar a operadora de saúde a fornecer ao agravado tratamento expressamente excluído da cobertura obrigatória, de eficácia não comprovada e em condições que ofendam o equilíbrio contratual e lhe ponham em situação de desvantagem excessiva*".

No ponto merece ser transcrita a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FORNECIMETO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.O fornecimento de medicamento para uso domiciliar (salvo para tratamento de neoplasias malignas) não é serviço de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos moldes do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e do art. 20, VI, da Resolução Normativa ANS nº 387/2015.

2.Não fere o Código de Defesa do Consumidor a negativa de cobertura de hormônio de crescimento e bloqueador de puberdade para tratamento domiciliar de eficácia controversa na espécie. **O aludido tratamento não se cuida de serviço essencial à natureza do contrato de assistência à saúde, não implicando em terapia fundamental para saúde/sobrevida/cura do paciente**. Cuida-se de tratamento eletivo, cuja efetividade é duvidosa no caso do agravado, conforme parecer técnico fundamentado acostado aos autos.

3.Não é razoável obrigar a operadora de saúde a fornecer tratamento expressamente excluído da cobertura obrigatória, de eficácia não comprovada e em condições que ofendam o equilíbrio contratual e lhe ponham em situação de desvantagem excessiva.

4.Ausente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), é de se indeferir a tutela de urgência, reformando-se a decisão originária que concedeu tal providência. (TJPE, Agravo de Instrumento 0003904-53.2017.8.17.9000, Relator Des. José Fernandes de Lemos, data julgamento: 03.10.2017).

No mesmo trilhar julgado do TJDF:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO TITULAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL.**

I. Aquele que contrata seguro privado de assistência à saúde é parte legítima para a causa que tem por objeto o fornecimento de medicamento a um de seus beneficiários.

II. **Em se cuidando de medicamento ministrado fora do regime de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial de urgência ou de emergência, a exclusão contratual encontra suporte no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e da Resolução Normativa 387/2015 da ANS**.

III. Recurso conhecido e provido. (TJDF, 4ª Turma Cível, Relator Des. James Eduardo Oliveira, data de julgamento: 11.10.2017).

É de se destacar, ainda, que os precedentes em que o STJ e demais tribunais têm entendido pela obrigatoriedade de fornecimento de medicamento pelo plano de saúde para uso domiciliar pelos consumidores, referem-se a circunstâncias diversas dos autos, como, por exemplo, **para tratamento de neoplasias malignas ou de doenças graves e crônicas** (a este respeito: AgInt no AREsp 918635; REsp 1641135/SP e AgRg no REsp 1541966/RS).

Deste modo, não tendo o plano de saúde a obrigação de fornecer os medicamentos vindicados, não há como acolher os pedidos de obrigação de fazer e nem em danos morais, já que não há conduta ilícita ou irregular praticada pela parte ré.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão atrial, ao tempo que **extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.**

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em sintonia com o art. 85, § 2º do CPC/2015, cujo exigibilidade encontra-se suspensa em face do benefício da justiça gratuita deferida à parte autora na decisão inaugural (ID Ultrapassada as questões prefaciais, passo ao mérito propriamente dito.).

Oficie-se ao Desembargador Relator do **Agravo de Instrumento nº 0054886-27.2024.8.17.9000**, a fim de cientificá-lo da presente sentença.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

Intime-se, também, o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, 26 de fevereiro de 2025.

Virgínia Gondim Dantas

Juíza de Direito

1 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/Processo/movimentar.seam?newTaskId=5325334132&idProcesso=6597879&edicao=true&iframe=true#sdfootnote1an MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Danuel Mitidiero. – 3.ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 6 Mb; PDF. Pág.269.

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
26/02/2025 20:30:34
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 196754354

25022620303478900000191743683

IMPRIMIR GERAR PDF